

La teoría de la autoeficacia, desarrollada por Bandura como parte de la teoría del aprendizaje social, está enfocada en el cambio de comportamiento.

La mejora de la autoeficacia de una persona se basa en cuatro fuentes de información:

- **logros de rendimiento,**
- **aprendizaje vicario o modelado,**
- **persuasión verbal y**
- **autoevaluación de las respuestas emocionales y fisiológicas**

Al formar un juicio de eficacia, las personas tienen que sopesar e integrar la información de las diferentes fuentes.

ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA AUTOEFICACIA

Logros de rendimiento

- Dividir la tarea o el contenido en partes pequeñas
- Dar oportunidad para aprender y practicar cada trozo
- Dar retroalimentación destacando los éxitos
- Invitar al paciente a establecer propósitos (contrato) o metas pequeños y realizables a corto plazo
- Evaluar el cumplimiento de los propósitos
- Establecer nuevos propósitos o metas

Una base importante para la autoeficacia es la atribución de la persona de éxitos o fracasos anteriores. Una persona que atribuye el éxito a una causa estable, como sus capacidades, tiene una mayor expectativa de éxito en una nueva tarea similar, mientras que una persona que atribuye el éxito a una causa inestable como la suerte no tendrá una mayor expectativa de éxito. Por lo tanto, la autoeficacia puede mejorarse atribuyendo el fracaso a causas inestables y atribuyendo el éxito a causas estables.

Las personas con diabetes necesitan que se les diga que los resultados positivos, como las mejoras en la glucosa en la sangre, son causados por sus propios esfuerzos, y no por accidente o por ayuda profesional.

El establecimiento de metas dirige y causa motivación para un comportamiento deseado. Las metas influyen en el logro porque motivan a las personas a esforzarse nuevamente y, por lo tanto, perseveran más tiempo en su tarea, dirigen la atención de los pacientes, mejoran su concentración y conducen a nuevas estrategias para tener éxito. Los objetivos deben ser específicos y suficientemente desafiantes, en lugar de fáciles; realistas y alcanzables. Los objetivos a corto plazo son más motivadores que los a largo plazo.

Aprendizaje vicario o por modelado

La segunda forma de desarrollar la autoeficacia es el aprendizaje indirecto, es decir, observar las experiencias de otras personas. Las propias capacidades de la persona se

juzgan en relación con los logros de esa otra persona. La fuerza de esta fuente de información sobre la autoeficacia está fuertemente influenciada por la comparabilidad de los modelos de acuerdo con experiencias compartidas y características personales similares.

Los modelos que tienen éxito lentamente, por ensayo y error, son mejores que los que tienen éxito al instante, sin problemas. El mejor modelo es una persona que tiene problemas, que lucha por superarlos y que se adapta día a día. El modelado también se puede utilizar con otros medios educativos como televisión, videos, folletos y libros de texto.

Un tipo especial de modelado que puede mejorar la autoeficacia es el "automodelado". Esta técnica ayuda a los pacientes a cambiar su comportamiento después de ver un video de sí mismos que muestra el comportamiento deseado porque las personas están interesadas en videos de sí mismos, lo que les hace prestar atención al video.

También se puede usar el juego de roles donde se demuestra y observa el comportamiento deseado. Los participantes también tienen la oportunidad de practicar un comportamiento y obtener retroalimentación de los miembros del grupo y los líderes del grupo.

Persuasión verbal

- Establecer a los pacientes metas mas altas, pero siempre realistas y alcanzables
- Transferencia de conocimiento: qué se debe hacer y por qué

A los pacientes se les dice que tienen la capacidad de tener éxito, ya que las personas tendrán más confianza en sí mismas si los demás tienen confianza en sus capacidades.

La persuasión verbal también puede estimular a las personas a establecer metas más altas de lo que habrían hecho por sí mismas. La retroalimentación positiva también puede ser vista como una especie de persuasión. Es importante, por supuesto, atribuir el éxito a los propios esfuerzos del paciente.

Para las personas con diabetes, la persuasión verbal consiste principalmente en la transferencia de conocimiento: los pacientes necesitan saber qué es lo que importa antes de que puedan ser convencidos de cambiar su comportamiento. Una vez que los pacientes tienen una idea de las razones por las que tienen que cambiar su comportamiento y saben cómo tienen que cambiar, necesitan ser estimulados para comenzar a hacer cambios en su comportamiento.

Autoevaluación de las respuestas emocionales y fisiológicas

- Aprender a reevaluar las respuestas emocionales: controlar el estrés
- Aprender a reevaluar las respuestas fisiológicas: efectos del ejercicio, o algún estrés físico adicional

Las personas que se sienten estresadas juzgarán su autoeficacia más negativamente que las personas que se sienten relajadas. Además, un estado de ánimo positivo aumenta la

autoeficacia y un estado de ánimo negativo lo disminuye. La autoeficacia se puede aumentar mejorando la situación física del paciente, reduciendo el estrés y disminuyendo las emociones negativas, así como corrigiendo las interpretaciones falsas de la situación física del paciente. La intensidad de las reacciones emocionales y físicas no es tan importante como la forma en que se observan e interpretan.

Las personas con diabetes tienen que aprender a anticipar los trastornos de la glucosa en la sangre por el estrés, la alimentación y el ejercicio físico. El estrés puede influir en la regulación de la diabetes y conducir a trastornos metabólicos. A menudo ocurren tres tipos de miedo: miedo a inyectarse, miedo a las complicaciones y miedo a la hipoglucemia. Los profesionales de la salud deben ser conscientes de estos temores.

Combinación de fuentes

Al formar un juicio de autoeficacia, la información de las cuatro fuentes debe integrarse. Se recomienda utilizar la teoría de la autoeficacia en el desarrollo de programas educativos para personas con diabetes. Las cuatro fuentes de información sobre la autoeficacia deben utilizarse con diferentes métodos de aprendizaje. Por ejemplo, cuando las personas están aprendiendo a medir e interpretar la glucosa en sangre, el educador primero tiene que explicar las ventajas de estas mediciones y proporcionar el conocimiento necesario. Este procedimiento debe repetirse hasta que las personas con diabetes tengan éxito. Convencer a los pacientes de sus capacidades es importante. Además, es importante un ambiente relajado y libre de estrés, porque el miedo puede tener un efecto negativo en la autoeficacia.

CONCLUSIONES

Las personas con diabetes pueden hacer gran parte de su tratamiento por sí mismas; sin embargo, por lo general, los cambios en el comportamiento son necesarios. Las intervenciones basadas en la teoría cognitiva social de Bandura muestran los mejores resultados.